

12/11/2020

ANTENOR PEREIRA DA COSTA	
HD:	
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	IAH: 21.7 e/h
PA:	SpO ₂ = 82%
OXIMETRIA:	
14	P = 82 cmH ₂ O
12	Percentil = 22.0
21	IAH = 1.2
	M. de uso: 6hrs
	fua
28	P = 82
12	Fuga = 33.6
21	M. de uso: 5h49'
	Bem adaptado
	fua
22/01	P = 8.7 cmH ₂ O
22	Fuga = 29.6 e/min
	M de uso: 6hrs
	IAH = 0.8 / ev
	fua
09/03	P = 8.7 cmH ₂ O
22	Fuga 37. e/min
	IAH = 0.6 / ev
25/05	P = 8.6 cmH ₂ O
22	IAH = 0.5 / ev
	M de uso: 6hr
	Troca filtro
	fua
31/08	P = 8.5 cmH ₂ O
22	IAH = 0.5 / ev
	M. de uso: 6.44hrs
	Bem adaptado.
	fua
27/10	P = 8.2 cmH ₂ O
22	IAH = 0.8 / ev
	M. de uso: 5h 18'
	ajuste masc.
	fua
01/12	P = 7.8 cmH ₂ O
22	IAH = 0.7
	M. de uso: 5h38'
	Fuga = 36 e/min
	fua

13/02
23 $P = 8.5$ / mediana: 6.2

m. de uso: 5m

IAH = 0.6 e/h

Bem adaptado, sem queixas

De

13/04
23 $P = 5.0$ cmH₂O

IAH = 0.6 e/h

m. de uso: 6h00

Fuga = 9.2 l/min.

sem queixas p/ m. de uso

fuc

21/06
2023 $P = 6.3$ cmH₂O

IAH = 0.5 e/h

m de uso = 5h34 min

fuga = 6.9 l/min

Auto: 5 à 10 cmH₂O

} lavar rosto
lavar + horas à noite

23/08

2023 $P = 6.5$ cmH₂O P95%: 8.8 cmH₂O

IAH = 0.7 e/h

m de uso = 6h15 min

fuga = 5 l/min

} Bem adaptado
mas relata sono diurno

01/11

2023

$P = 6.2$ cmH₂O P95%: 8.6 cmH₂O

IAH = 0.8 e/h

m. uso = 6h05 min

fuga = 3 l/min

/ Boca seca

Bem adaptado.

Auto 5 à 10 cmH₂O.

24/01

2024

$P = 6.0$ cmH₂O

IAH = 0.5 e/h

fuga = 30 l/min

m de uso = 4h59.

P95% = 8.3 cmH₂O

- Boca seca

sugiro 4 horas de uso.

03/04

24

$P = 5.9$ cmH₂O

IAH = 0.8 e/h

fuga 6.7 l/min P95%: 26.9 l/min

m. de uso: 4h20m

P95% = 7.9 cmH₂O

Oriento sobre tempo
de utilização do aparelho

Natacha

07/06

24

$P = 6$ cmH₂O Percentil: 8.3 cmH₂O

IAH = 0.4 e/h

fuga: 23.4 l/min

m. de uso: 5h25m

natacha

18/08 P = 6.2 cmH₂O ↓ P p/ 7 cmH₂O

24 fuga = 5.2 l/min

IAH = 0.5 e/h

m. de uso = 4h40'

fua.

07 P = 6.0 cmH₂O

11 IAH = 0.6 e/h

24 m. de uso: 5h

fuga = 3.6 lpm

fua.

16/01 P = 5.7 cmH₂O (Auto)

25 IAH = 1.0 e/h

m. de uso: 4h15'

fuga = 3.3 lpm

fua claudia

23/04 P = 6.0 med

nao usa 6 dias

IAH = 0.5 e/h

m uso = 5h30 min

fuga = 23 l/min

Silvia

23/07 P = 6.0 med Percentil: 6.9 cmH₂O

Auto: 5 a 7 cmH₂O.

2025 IAH = 0.5 e/h

m uso = 5h12 min.

nao usa 10d + 10h

fuga = 34 l/min

Silvia

LAUDO DA POLISSONOGRAMA



CENTRO DE TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO

NOME: Antenor Pereira da Costa

EXAME nº: 503-2

SOLICITADO POR: Dra. Rosemeiry Tereza Marçal

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez CRM: 69730

Especialista em Medicina do Sono - Sociedade Brasileira de Sono

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

DATA: 24/0/2009

IDADE: 56 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h28min e concluído às 06h02min. A latência para o sono foi de 17,5 minutos e a latência para o sono REM, de 91 minutos. O tempo total de sono foi de 313 minutos, com eficiência de sono (T T S / T T R)* de 79%. A distribuição do sono mostrou 18,4% de estágio 1, 58,1% de estágio 2, 15,7% de estágio 3 e 4 e 7,8% de sono REM. No período total de sono permaneceu 81 minutos em vigília, ocorreram 170 microdespertares (índice: 32,6/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 22,2/hora, sendo 14 apneia/hora e 8,2 hipopneia/hora. O número total de eventos respiratórios foi de 116, sendo 3 mistos, 111 obstrutivos e 2 centrais. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 82%.

(*) T T S $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono T T R $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registrou o aumento moderado do índice de apneia/hipopneia (22,2/hora; normal até 4/hora; moderado: 15 a 30 eventos/hora) associado aos episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e eventos bradi e taquicárdicos, com arritmia. Observaram-se também episódios de redução do fluxo aéreo que terminavam em despertares e, em alguns, dessaturações.

O ronco foi contínuo e alto.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 17,5 min; normal até 20 min). A latência para o sono REM foi normal (91 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 79%; normal: 90% ou acima) e microdespertares (170; índice: 32,6/hora; normal até 9/hora). Registrou-se o aumento das porcentagens dos estágios 1, estágio superficial do sono (18,4%; normal: 5-8%), 2 (58,1%; normal: 45-55%) e 3-4 (15,7%; normal: 10-11%), e a redução da porcentagem do sono REM (7,8%; normal: 20%).

Escala de Sonolência de Epworth: 9 (normal até 10; máximo: 24).

Conclusão final: exame compatível com o ronco e a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
24/0/2009

LAUDO DA POLISSONOGRAMA



NOME: Antenor Pereira da Costa
EXAME nº: 503
SOLICITADO POR: Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
DATA: 07/03/2006
IDADE: 53 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23:40 horas e concluído às 06:07 horas. A latência para o sono foi de 1,5 minuto e a latência para o sono REM, de 81 minutos. O tempo total de sono foi de 323 minutos, com eficiência de sono (TTS / TTR)* de 83%. A distribuição do sono mostrou 15,5% de estágio 1, 74,9% de estágio 2, 0% de estágio 3 e 4 e 9,6% de sono REM. No período total de sono permaneceu 64 minutos em vigília, ocorreram 166 micro-despertares (índice de 30,8/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apnéia/hipopnéia foi de 21,7/hora, sendo 1,1 apnéia/hora e 20,6 hipopnéia/hora. O número total de eventos respiratórios foi de 117, sendo 4 mistos, 113 obstrutivos e 0 central. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 97%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 74%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registrou o aumento moderado do índice de apnéia/hipopnéia (21,7/hora; normal até 4/hora; moderado: 15 a 30 eventos/hora) associado aos episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, principalmente no decúbito dorsal e/ou durante o sono REM, aos micro-despertares e aos eventos bradi e taquicárdicos (com ritmo sinusal). Além disso, observaram-se episódios de redução do fluxo aéreo (aumento da resistência) que terminavam em micro-despertares e dessaturações da oxi-hemoglobina – esses eventos não foram contados como hipopnéias.

O ronco foi intermitente e baixo.

O paciente adormeceu logo (latência para o sono: 1,5 min; normal até 20 min). A latência para o sono REM foi normal (81 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares noturnos (eficiência do sono reduzida: 83%; normal: 90% ou acima) e pelos micro-despertares (166; índice de micro-despertares: 30,8/hora; normal até 9/hora). Registrou-se o aumento das porcentagens dos estágios 1, estágio superficial do sono (15,5%; normal: 5-8%), e 2 (74,9%; normal: 45-55%), a redução da porcentagem do sono REM (9,6%; normal: 20%) e a ausência dos estágios 3 e 4 (0%; normal: 10-11%).

Conclusão final: exame compatível com a síndrome da apnéia-hipopnéia obstrutiva do sono (índice moderado) e o ronco.

Dr. Alberto Jorge Remesar López
CRM - 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar López CRM: 69730